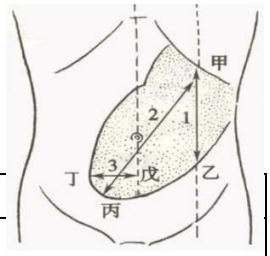
（二）门静脉高压



脾静脉回流入门静脉

1.**脾肿大**（门脉高压**最早**的表现，且**代偿期即可出现**）

①左肋下**触及**边界清楚、质韧、**有切迹**、随呼吸运动的肿块

②分度

轻度	脾不超过肋下 2cm
中度	脾超过肋下 2cm、但在脐水平线以上
重度/巨脾	脾超过脐水平线或 ttsx 前正中线。常见于**慢粒/慢性髓系白血病 CML**、慢性疟疾、骨髓纤维化

看到巨脾优先考虑CML

2.**脾功能亢进**

①先血小板减少、随后血小板和白细胞减少、严重者**全血细胞均减少**

②治疗

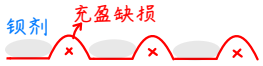
《内科学》	不提倡全脾切除术，以部分脾动脉栓塞、TIPS 为主
《外科学》	脾切除术是治疗脾亢最有效的方法，几乎全部的断流术、部分的分流术均包含脾切除术 脾动脉栓塞治疗脾亢的效果不确切、并发症多，主要用于不愿手术或不耐受手术者

肝功能不全和门脉高压都可导致消化吸收不全、营养不良与肌少症

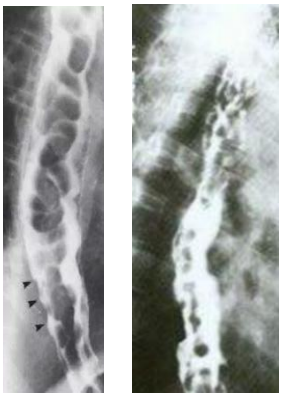
3.消化吸收不良、营养不良与肌少症：**胃肠道淤血、水肿**

肝硬化分期:即使是代偿期也可以有侧支循环形成

4.**侧支循环形成（门脉高压最特征/最有价值的表现）**



胃底食管静脉曲张导致黏膜鼓起来,无钡剂填充



蚯蚓样充盈缺损

侧支循环（门脉高压失代偿最特征/最价值）

① 食管胃底静脉曲张（最主要）
- 钡餐示串珠/蚯蚓样充盈缺损
- 胃镜诊断：红色征很严重 要破了
- 破裂出血 → 上消化道出血 最常见原因:消化性溃疡（最常见并发症）（上消化道出血次常见原因 20-25%）

② 腹壁静脉曲张
- 海蛇头样（脐周血回流：脐以上向上+脐以下向下上上下下）
- 静脉连续性潺潺音/嘤嘤音

③ 直肠静脉曲张 → 本质:曲张静脉 痔疮→便血

④ 腹膜后 Retzius 静脉曲张 脾肾分流 ⑤

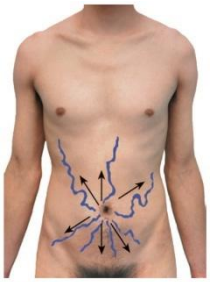


图 3-6-5　门静脉高压时腹壁浅静脉血流分布和方向



图 3-6-6　下腔静脉梗阻时腹壁浅静脉血流分布和方向

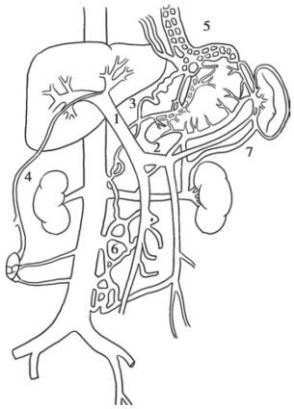


图 4-15-1　门静脉高压侧支循环开放
1. 门静脉；2. 脾静脉；3. 胃冠状静脉；4. 脐静脉；5. EGV；6. Retzius 静脉；7. 脾肾分流。

